

Prioridad y distancia: una jornada Sur, una Norte

Regla

Asignaría una jornada a Sur y una a Norte. Mi regla prioriza primero controles vencidos y, ante capacidad restante, mayor barrera de viaje y ausencia de clínica fija. No pretende maximizar el número bruto de solicitudes atendidas, sino reducir una combinación explícita de urgencia registrada y barrera geográfica.

Cálculo

Sur tiene 20 controles prioritarios y 35 solicitudes. Una jornada de 24 cubriría hasta los 20 prioritarios y dejaría 4 cupos para otras solicitudes; quedarían 11 solicitudes sin cupo. Norte tiene 12 prioritarios y 42 solicitudes: 24 cupos cubrirían esos 12 y hasta 12 adicionales; quedarían 18 solicitudes. Centro, no elegido, tiene 18 prioritarios y 60 solicitudes; una jornada también podría llenarse, pero cuenta con clínica fija cinco días por semana y viaje medio de 20 minutos.

La regla sacrifica throughput visible: Centro tiene la mayor lista y menor inasistencia previa, por lo que probablemente usaría los 24 cupos. A cambio, Sur y Norte tienen viajes de 70 y 55 minutos y menor disponibilidad fija. Ese es el trade-off, no una conclusión de que Centro carece de necesidad.

Evidencia situada y factibilidad

La enfermera de Sur advierte que la unidad no tiene ecógrafo. La cita no cuantifica cuántos casos lo requieren, pero obliga a coordinar derivaciones antes de ofrecer cupos; de otro modo una consulta móvil puede no completar la atención. La voz de Norte describe un horario de bus que la media de 55 minutos no captura. No la convierto en porcentaje de toda la zona.

La inasistencia previa podría hacer que queden cupos ociosos, pero no sé si corresponde a clínica fija, móvil o a personas únicas. Usaría confirmación por canal elegido por cada persona, lista de reemplazo sin nombres en el brief y registro agregado de cupos ofrecidos, usados, derivados y tiempo de viaje. Después del piloto revisaría si las prioridades atendidas y derivaciones completadas justifican repetir la regla. La confianza comunitaria no puede declararse lograda con esta tabla; requiere consulta posterior.

Comparación de asignaciones descartadas

Dos jornadas en Centro podrían ofrecer 48 cupos, cubrir como máximo sus 18 controles vencidos y dejar 12 solicitudes sin cupo; priorizarían volumen y probable utilización, pero ninguna de las zonas con viaje largo recibiría visita. Dos en Sur cubrirían sus 35 solicitudes como máximo y dejarían 13 cupos ociosos porque no se transfieren; atenderían 20 prioritarios, menos que mi combinación Sur-Norte. Centro-Sur cubriría hasta 38 prioritarios, seis más que Sur-Norte, pero dejaría Norte sin servicio pese a cero días de clínica fija.

Elijo Sur-Norte porque mi regla da más peso a barrera geográfica después de cubrir urgencia registrada. No digo que domine todas las reglas. Una regla de máximo número de prioritarios elegiría Centro-Sur; una de uso de capacidad podría preferir Centro-Norte. Hacer explícitas esas alternativas permite al comité discutir el valor sacrificado.

Operación del mes piloto

Publicaría la regla por zona sin nombres, abriría confirmaciones una semana antes y mantendría una lista de reemplazo local. En Sur, antes de la jornada, el equipo identificaría qué tipos de cita requieren ecografía y acordaría un circuito de derivación; no recopilaría diagnósticos en el brief. En Norte ofrecería horarios compatibles con el bus cuando fuera posible, porque la voz comunitaria advierte una barrera que la media de viaje no describe.

El tablero agregado distinguiría cupos ofrecidos, confirmados y usados; controles prioritarios atendidos; derivaciones indicadas y completadas; solicitudes no cubiertas; e inasistencia. Compararía zonas sin publicar celdas pequeñas que permitan reidentificación. Después informaría si la regla produjo el acceso que pretendía y abriría revisión antes de repetirla.

Desempates y contingencias de la asignación

Si una zona rechazara la fecha o no pudiera asegurar personal, no trasladaría sus cupos a mitad de jornada: volvería a aplicar la regla entre las zonas factibles y documentaría el cambio. Si Sur no logra un circuito de derivación para ecografía, la visita todavía puede atender consultas compatibles, pero el equipo debe comunicar el límite antes de confirmar. La frase de la enfermera justifica preparar esa contingencia; no permite estimar cuántos cupos se perderán.

Para los empates mantendría un orden público: controles vencidos, ausencia de clínica fija, tiempo de viaje y, por último, solicitudes totales. Esta secuencia podría elegir Centro-Sur bajo una prioridad estrictamente cuantitativa o Sur-Norte cuando la barrera geográfica actúa como umbral. No ocultaría esa sensibilidad bajo una suma única, porque la consigna deja una ambigüedad real entre máximo volumen y acceso equitativo.

Al cierre distinguiría tres resultados: asignación prevista, capacidad efectivamente ofrecida y atención completada. La inasistencia histórica no autoriza reducir por anticipado una zona, pero sí exige una lista de reemplazo y un reporte de utilización. Tampoco inferiría diagnósticos de las solicitudes ni publicaría citas textuales que puedan identificar a alguien. El brief conserva las voces comunitarias como razones situadas, no como estadísticas de toda la población.